UE D1 · Communication et relation de soins

Théorie et compétences en communication

Le message circule

Émetteur → message → canal → récepteur ; le bruit perturbe, le feedback vérifie la compréhension.

Shannon et Weaver : modèle linéaire utile, mais l'échange humain se construit dans les deux sens.

L'information est filtrée par le vécu et la culture : omission, généralisation et distorsion peuvent modifier son sens.

Trois canaux à observer

Verbal : mots. Paraverbal : ton, débit, volume, silences. Non-verbal : regard, posture, mimiques, distance, toucher.

« Ça va » + bras croisés + regard fuyant : rechercher le sens sans conclure hâtivement.

Palo Alto · cinq axiomes

1. Même le silence communique. 2. Tout message a un contenu et indique une relation.

3. Chacun ponctue l'échange à sa façon. 4. Mots et indices analogiques peuvent être cohérents ou discordants.

5. Relation symétrique ou complémentaire : en soins, éviter la domination.

Écoute active et mise en situation

Rogers · relation d’aide

Empathie : comprendre le vécu de l’autre. Congruence : accorder attitude et paroles. Regard positif inconditionnel : accueillir sans jugement.

Écouter pour comprendre

Être disponible, laisser un silence, poser une question ouverte, reformuler et vérifier ce qui a été compris.

Patient silencieux après un diagnostic : reconnaître les signes non verbaux et ouvrir un temps de parole.

Obstacles → réponses utiles

Fausse réassurance → explorer l’inquiétude. Jargon → mots simples et vérification.

Jugement, conseils précipités, interruption → reformulation, écoute et respect du rythme.

Famille en colère : entendre l’angoisse et le besoin d’information avant de répondre au contenu.

Styles : passif, agressif, manipulateur, affirmé. S’affirmer = exprimer clairement besoins et ressentis dans le respect d’autrui.